

Імобілізація верхньої кінцівки

Сценарій (Імобілізація верхньої кінцівки)

Ви – лікар з медицини невідкладних станів. В складі бригади екстреної медичної допомоги ви прибуваєте на виклик до чоловіка 58 років з травмою правої верхньої кінцівки.

Об'єктивно: В області ушкодженої кінцівки відмічається деформація передпліччя на протязі, виражений набряк м'яких тканин крепітація кісткових фрагментів, посилення болю при пальпації.

Необхідно: Встановити попередній діагноз, визначити тактику надання невідкладної допомоги,

7. Матеріально-технічне оснащення та параметри програмування манекенів.

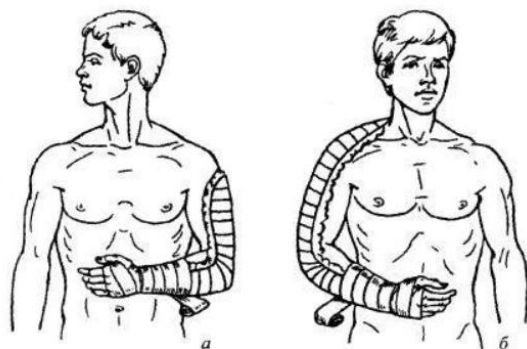
Приміщення, що імітує вулицю, обов'язково повинно включати:

- перелік меблів та іншого обладнання

№ п/п	Перелік меблів та іншого обладнання	Кількість
1	Стіл	1 шт.
2	Стілець	1 шт.
3	Каремат чи ковдра на якій буде лежати манекен	1 шт.
4	Манекен людини з переломом верхньої кінцівки (при необхідності можливо замінити на манекен окрема верхня кінцівка)	1 шт.
5	Транспортні шини Крамера чи вакуумні шини	5 шт.
6	Бинти	

- перелік медичного обладнання (багаторазового використання)

№ п/п	Перелік медичного обладнання	Кількість
1	Транспортні шини Крамера чи вакуумні шини	1 шт.



Мал. 67. Транспортна імобілізація драбинчастої шини Крамера у разі переломів кісток передпліччя (а) і плеча (б)



ШИНИ КРАМЕРА

ВАКУУМНІ ШИНИ

11. Алгоритм виконання практичних навичок та вирішення клінічних кейсів

Алгоритм виконання	Форма представлення
1.Продемонструвати навички комунікації.	

1.1	Встановлення контакту з постраждалим (привітатись, представитися, позначити свою роль). Відповідь на питання лікаря до постраждалого надає екзаменатор.	<i>Сказати</i> Доброго дня. Я лікар з медицини невідкладних станів, що тут сталося? <i>Відповідь:</i> Йшов по вулиці оступився втратив рівновагу і впав на витягнуті руки відчув гострий біль, і хрускіт в області передпліччя справа. Побачив деформацію кінцівки викликав швидку.
1.2	Одягнути медичні рукавички	<i>Виконати</i>
2. Виконання навички		
2.1	Одяг з постраждалого можна не знімати, при необхідності вирізають в одягу вікно.	<i>Виконати</i>
2.2	Перед накладанням шини при необхідності провести знеболення, так як маніпуляція на пошкодженій ділянці звичайно болісна.	<i>Сказати</i>
2.3	Моделювання шини. Підгонка шин за формою та розміром ураженого сегменту. Підгонка шин здійснюється за здоровою кінцівкою, подібною до ураженої.	<i>Виконати</i>
2.4	Довжина шини. Шина повинна обов'язково фіксувати не менше двох сусідніх суглобів, вище та нижче місця ураження, а при переломах плеча та стегон - не менше трьох сусідніх суглобів.	<i>Сказати</i>
2.5	Шина накладається у функціонально вигідному положенні. Для верхньої кінцівки таке положення буде - відведення плеча на 30 градусів у плечовому суглобі, згинання передпліччя у ліктьовому суглобі до 90°, кисть злегка зігнута.	<i>Виконати</i>
2.6	Шина повинна бути надійною. Вона з часом під дією зовнішніх факторів (сонце, дощ, вітер, температура) не повинна змінювати своїх фіксуючих, якостей.	<i>Сказати</i>
2.7	Кріпиться шина бинтуванням до центру, обережно, не завдаючи додаткових болів потерпілому.	<i>Виконати</i>
2.8	Зняти медичні рукавиці	<i>Виконати</i>
3. Встановити попередній діагноз		
3.1	Закритий перелом дистального відділу кісток передпліччя праворуч	<i>Сказати</i>
4. Визначення тактики ведення та лікування		
4.1	Імобілізація кінцівки, знеболення, госпіталізація	<i>Сказати</i>

Сценарій